

V / La santé : entre privatisation limitée et couverture universelle

Du point de vue de la protection sociale, la question de la santé (et par extension, dans ce chapitre, celle de l'autonomie) est un enjeu à deux facettes bien distinctes, bien qu'en relation étroite : la prise en charge financière des soins d'une part, leur organisation et production d'autre part.

Une assurance sociale universelle mais partielle : de l'assurance volontaire à l'assurance sociale unique et obligatoire

En France, parallèlement à l'assistance médicale gratuite instituée pour les pauvres en 1893, la prise en charge des dépenses de santé se fait jusqu'au début du xx^e siècle sur le mode de l'assurance individuelle et volontaire, par l'adhésion à une mutuelle ou à une assurance professionnelle. Adhérer à une assurance maladie est rendu obligatoire pour les salariés (en dessous d'un certain salaire) par les lois sur les assurances sociales de 1928-1930. Il s'agit alors d'éviter le transfert vers l'assistance publique des frais de soins des personnes non assurées, que les salariés et les employeurs devraient pouvoir supporter eux-mêmes [Laroque, 2015 ; Renard, 1995]. Mais, dès cette époque, les médecins libéraux et les organisations mutualistes défendent leurs intérêts propres et contribuent à configurer le système. Les médecins libéraux imposent la liberté de fixer leurs honoraires en accord avec le patient. Les mutuelles refusent l'instauration d'une assurance sociale unique : des caisses départementales sont alors créées et l'affiliation est obligatoire pour les salariés non couverts par ailleurs. Des tarifs de remboursement à l'acte sont définis localement et constituent une base de remboursement assortie d'un « ticket modérateur », expression qui apparaît en 1928 et désigne la part (alors de 15 %)

de la consultation non remboursable par l'assurance [Laroque, 2015]. Mais ces tarifs, indicatifs, ne s'imposent pas au médecin et servent juste à calculer le montant remboursé : dans la réalité, le reste à payer est supérieur.

Avec la création de la Sécurité sociale en 1945, les assurances existantes se regroupent dans des caisses départementales de Sécurité sociale. Seule une partie des frais de soins est remboursée : les caisses départementales fixent un tarif de référence, mais on reprend le principe du ticket modérateur alors que les médecins ont la liberté de pratiquer des honoraires plus élevés que le tarif remboursé. Tous les salariés — y compris les cadres — et leur famille sont désormais obligatoirement affiliés (un « plafond de la Sécurité sociale » est mis en place) (chapitre II). Bien qu'étendue aux étudiants en 1947, l'assurance sociale obligatoire ne s'applique alors pas aux non-salariés.

Généralisation puis extension de l'assurance maladie obligatoire

La couverture de l'assurance maladie s'étend progressivement après 1950. En premier lieu, cette extension correspond à celle, considérable, du salariat : le taux d'emploi des femmes augmente tandis que l'indépendance diminue. De plus, les professions initialement non couvertes rejoignent l'assurance obligatoire (dans des régimes spéciaux) au cours des années 1960 : les agriculteurs en 1961, puis les artisans et commerçants en 1966. Aussi, au milieu des années 1990, si l'assurance maladie n'est pas encore universelle, elle est déjà généralisée. C'est d'ailleurs un des arguments invoqués à la création de la contribution sociale généralisée (CSG) : puisque l'assurance maladie concerne tout le monde, au-delà du seul salariat, elle doit être adossée à un financement « universel », assis sur tous les revenus et non seulement sur les salaires. L'assistance permettant aux personnes sans ressources de bénéficier de soins gratuits (aide médicale, dispensaires) a progressivement reculé à mesure que l'assurance maladie s'universalise. L'universalisation n'est parachevée toutefois que progressivement ; d'abord avec la création en 2000 de la couverture maladie universelle (CMU), qui garantit l'affiliation à l'assurance maladie aux personnes sans ressources et le financement d'une complémentaire santé de base (voir *infra*). En 2016, la Protection universelle maladie (Puma) consacre le fait que toute personne travaillant ou résidant régulièrement en France est affiliée *de droit* à l'assurance maladie obligatoire. Cela maintient malheureusement l'exclusion des personnes en situation irrégulière, qui relèvent de l'aide médicale d'État (AME), laquelle assure une prise en charge de certains soins urgents pour les personnes en

Encadré 2. Les prestations de l'assurance maladie

L'assurance maladie verse principalement deux types de prestations : les remboursements des frais de soins (consultation, médicaments, hospitalisation...) d'une part, les indemnités journalières d'autre part. Pour les frais de soins (consultations, actes médicaux, hospitalisations, transport sanitaire, médicaments), la prise en charge est totale ou partielle. Les indemnités journalières équivalent à 50 % du salaire journalier de base pour les personnes en arrêt maladie ou en maladie professionnelle. L'employeur peut compléter ces indemnités jusqu'à 90 % du salaire journalier de base ; il y est souvent obligé, dans le privé, par les conventions collectives ou les accords d'entreprise. Les congés

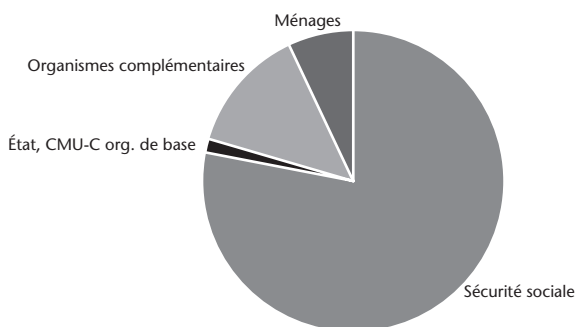
maternité, gérés eux aussi par l'assurance maladie, sont rattachés dans les comptes de la protection sociale au risque « famille » (chapitre VII). Les soins et les indemnités journalières liés à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles homologués sont financés par la branche accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) qui prélève des cotisations spécifiques aux employeurs. Les prestations sociales relevant du risque maladie de la Sécurité sociale et de l'État s'élevaient en 2018 à 186 milliards d'euros (8 points de PIB), dont 161 milliards de frais de soins et 12 milliards d'indemnités journalières (dont 3 milliards pour la branche AT-MP). Enfin, 23 milliards de « prestations sociales » étaient versées par des organismes privés ayant un caractère de solidarité entre affiliés (mutuelles, institutions de prévoyance, etc.).

situation irrégulière et aux ressources faibles. Cette exclusion n'a aucune rationalité économique, sanitaire ou sociale et est régulièrement dénoncée notamment par les associations de solidarité avec les migrants, qui demandent l'intégration de ces personnes à la Puma plus protectrice.

Les dépenses de santé, entre prise en charge sociale et privatisation

Les comptes de la santé [Drees, 2019a] rendent compte du coût de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM), autrement dit des frais de soins. L'essentiel de la dépense de consommation de services et de biens médicaux (78 %) est pris en charge par l'assurance maladie de la Sécurité sociale (l'« assurance maladie obligatoire » — AMO) et par l'État (1,5 %). La partie non prise en charge est appelée « reste à charge » et est financée de manière privée. La plus grande part du reste à charge est payée par les organismes complémentaires d'assurance maladie (Ocam) que sont les mutuelles, instituts de prévoyance ou d'assurance (13,4 % de la CSBM). Enfin, le résidu

Figure 4. Prise en charge des frais de soins



(les frais non pris en charge par une assurance sociale ou une complémentaire privée, dont notamment les franchises médicales) est payé directement « de la poche » des patients et s'élève à 7 % de la dépense totale.

Ces chiffres (figure 4) soulignent le rôle central de la Sécurité sociale tout en masquant une tendance réelle à la privatisation de la prise en charge des soins de ville, compensée en partie par une meilleure prise en charge de certaines maladies chroniques. En effet, la plupart des soins primaires (consultations en ville, médicaments, analyses médicales) ne sont pris en charge qu'à hauteur de 70 % au maximum de leur tarif conventionné. Les soins dentaires (en particulier les prothèses) et les prothèses optiques ou auditives sont particulièrement mal remboursés par la Sécurité sociale. Plusieurs études estiment la prise en charge moyenne des soins de ville à hauteur d'environ 50 % seulement [Houssoy *et al.*, à paraître]. À l'inverse, les soins liés aux « affections de longue durée » (ALD) (diabète, cancer, autres maladies inscrites sur une liste) et les soins liés à la grossesse sont pris en charge à 100 % (sur la base du tarif de la Sécurité sociale) tandis que les hospitalisations sont prises en charge par l'AMO à hauteur de 80 %. L'accès à des soins extrêmement coûteux (médicaments, examens médicaux) ou très longs (maladies chroniques) ne dépend pas de la capacité du patient à les payer ou à souscrire à une complémentaire (contrairement à ce qui se passe par exemple aux États-Unis), ce qui constitue une protection forte pour les malades. La séparation entre « soins courants » et ALD est aussi une bonne affaire pour les assurances santé privées

car les soins courants représentent un marché très lucratif, tandis que les ALD sont un risque coûteux et difficilement assurable. Par ailleurs, la carte vitale (1999), l'informatisation et les évolutions réglementaires ont conduit au développement du « tiers payant » : alors que, au ^{xx} siècle, les patients avançaient leurs dépenses de santé en attendant leur remboursement, les assurances santé règlent directement les soins, ne laissant fréquemment au patient à régler lors de sa consultation que la partie qui ne sera pas prise en charge.

Une couverture complémentaire généralisée et inégalitaire

D. Tabuteau [2010] a nommé à juste titre « métamorphose silencieuse » le retrait progressif de l'AMO au profit des complémentaires santé dans la prise en charge des dépenses courantes de santé. En effet, comme personne ne souhaite avoir à faire face à des dépenses de santé imprévues (dont le montant peut être élevé), les « complémentaires santé » sont devenues de plus en plus utiles aux yeux des assurés : la plupart d'entre eux préfèrent payer régulièrement des primes d'assurance de plusieurs centaines d'euros par an plutôt que d'avoir à faire face à des dépenses de plusieurs milliers d'euros en cas de maladie. Les complémentaires santé, longtemps facultatives, sont désormais considérées comme indispensables par les pouvoirs publics : depuis le début des années 2000, les personnes les plus modestes voient le prix de leur complémentaire santé prise en charge en tout ou partie, en fonction de leur niveau de revenu, par l'État. Ce dernier, reconnaissant ainsi les insuffisances de l'assurance maladie, finance la complémentaire santé des personnes aux revenus modestes. Les anciennes aides (CMU-Complémentaire et aide à la complémentaire santé) ont été fusionnées en 2020 sous le nom « complémentaire santé solidaire » (CSS). Dans 90 % des cas, les personnes éligibles à la CSS choisissent comme complémentaire... la Sécurité sociale [Drees, 2019a] (ce que ne peuvent pas faire les autres assurés, contraints de recourir à une complémentaire privée) ! La complémentaire santé est également vue comme indispensable par une partie des partenaires sociaux : un accord interprofessionnel de 2013 (mis en œuvre en 2016) a rendu obligatoire l'adhésion à un contrat collectif d'entreprise (contrats qui étaient déjà quasiment généralisés, sauf dans les plus petites structures). Les inactifs, retraités, indépendants et fonctionnaires s'assurent pour leur part à titre individuel et volontaire à leurs propres frais (et à un prix plus élevé).

En 2018, 95 % des individus étaient couverts par une complémentaire santé. Toutefois, les complémentaires ne prennent pas toutes en charge un même niveau de dépenses. L'État définit un

« panier de soins » minimal couvert par tout contrat « solidaire et responsable », c'est-à-dire un contrat éligible aux aides publiques. Ce panier comprend notamment la prise en charge du ticket modérateur, du forfait hospitalier ou de la partie non remboursée des médicaments. Depuis 2019 et l'instauration du « 100 % santé », il garantit la prise en charge de dispositifs optiques, dentaires et auditifs référencés. Enfin, certaines dépenses courantes (notamment les « dépassements d'honoraires ») ou « de confort » (comme les chambres individuelles à l'hôpital, les soins paramédicaux non remboursés...) ne sont pas prises en charge par les contrats de base. Les organismes complémentaires proposent donc des contrats à des tarifs bien plus élevés pour les personnes qui peuvent se le permettre, voire des « surcomplémentaires » individuelles, pour compléter les contrats d'entreprise jugés insuffisants. Avoir accès à ces contrats permet notamment aux personnes aisées d'accéder à des consultations à des tarifs très élevés, avec une attente moindre. Ces mécanismes illustrent les grandes inégalités liées aux assurances complémentaires des mutuelles.

*De l'économie sociale à un marché de l'assurance :
l'évolution des « mutuelles »*

Historiquement, on distingue en France trois types d'organismes complémentaires d'assurance maladie (Ocam) : les mutuelles, les instituts de prévoyance et les assurances. Les mutuelles sont gérées par leurs adhérents, et l'adhésion y est individuelle et volontaire. Elles se sont organisées dans le cadre de la solidarité professionnelle, regroupant en leur sein l'essentiel des salariés de certaines professions (agriculteurs, enseignants) ou parfois les habitants d'un territoire. Les instituts de prévoyance, organismes paritaires cogérés par les syndicats et le patronat, ont pour activité principale l'organisation des assurances sociales (santé, prévoyance, retraite) pour les salariés des entreprises ou des branches. Les salariés sont le plus souvent obligés d'y adhérer dans le cadre d'une décision de l'employeur ou d'un accord collectif. Enfin, les assurances, organismes privés à but lucratif, ont des adhérents individuels volontaires.

Relevant de l'économie sociale, les mutuelles et les institutions de prévoyance pouvaient par le passé organiser des formes de solidarité entre leurs adhérents (cotisation proportionnelle au revenu, couverture uniforme des adhérents...). Mais l'évolution de la réglementation financière et le droit européen de la concurrence ont conduit le secteur à fortement évoluer depuis les années 2000. Les petits Ocam ont disparu et les grands organismes se sont

regroupés ; pour survivre, ils adoptent les pratiques de leurs concurrents (concurrence par les prix, différenciation des contrats...). Aussi, la différence entre les trois types d'Ocam s'est largement estompée, certains groupes réunissent par exemple des mutuelles et des assurances privées, et la solidarité entre assurés s'est affaiblie [Batifoulrier *et al.*, 2018].

Les travaux d'économie de l'assurance montrent depuis longtemps que, pour offrir une couverture solidaire à moindre coût, l'assurance santé obligatoire est plus efficace qu'un marché de l'assurance où les bien-portants se voient proposer des contrats moins chers alors que les personnes les plus exposées à la maladie se voient proposer des contrats très onéreux [Rothschild et Stiglitz, 1976]. À l'inverse, dès lors qu'ils sont en concurrence entre eux, les Ocam (même ceux qui relèvent de l'économie sociale) ne peuvent organiser ce niveau de solidarité et sont structurellement conduits à des pratiques commerciales agressives et peu solidaires. Certes, les Ocam ne sont pas autorisés à discriminer, mais ils peuvent proposer des couvertures différentes (plus ou moins bon remboursement de l'optique ou de certaines spécialités...) et établir une tarification en fonction de l'âge (des tarifs beaucoup plus élevés pour les seniors, qui sont statistiquement les plus gros consommateurs de soins). Ainsi, s'il subsiste au sein des mutuelles ou des institutions de prévoyance certaines pratiques solidaires dans la définition ou dans la tarification, pour l'essentiel, les complémentaires santé n'opèrent quasiment pas de redistribution entre leurs adhérents, au contraire de la Sécurité sociale dont le financement est très redistributif [Jusot *et al.*, 2016]. Seule exception, la taxe de solidarité additionnelle sur les Ocam contribue au financement de la Sécurité sociale et de la « complémentaire santé solidaire ».

Enfin, le système français de santé, superposant Sécurité sociale et complémentaires, est largement reconnu comme inefficace au plan économique [Dormont *et al.*, 2014] : il implique que chaque dépense de santé soit traitée administrativement deux fois par des organismes différents. De plus, les frais de gestion des Ocam sont beaucoup plus élevés que ceux de l'assurance maladie, qui bénéficie d'économies d'échelle et n'a pas à dépenser des sommes importantes en marketing pour acquérir de nouveaux assurés. Ce système à deux étages était historiquement justifié par la « liberté » de s'assurer, mais cet argument a perdu du poids maintenant que la complémentaire est généralisée et quasi obligatoire. Enfin, un système coûteux d'exemptions de cotisations subventionne la souscription des complémentaires santé d'entreprise, au détriment des recettes de la Sécurité sociale [Zemmour, 2015]. *A priori*, il serait

donc plus juste et moins coûteux de remplacer progressivement les Ocam par la Sécurité sociale, au moins pour ce qui est des activités d'assurance santé, quitte à laisser aux Ocam le soin de développer les autres activités pour lesquelles ils ont une expertise, à savoir la prévoyance, la prévention de risques spécifiques à une population, l'organisation de réseaux de soins, les services de confort. Cela dit, une telle évolution poserait d'autres défis : d'abord, celui de la régulation des prix et de la quantité de l'offre de soin (en particulier parce que les praticiens libéraux, les cliniques privées ou l'industrie pharmaceutique trouveraient en face d'eux une demande solvabilisée à l'infini) ; ensuite, celui du contrôle politique et administratif d'une telle structure ; enfin, celui de la « transition » aboutissant à la disparition progressive des complémentaires. Quoi qu'il en soit, le remplacement des complémentaires par la Sécurité sociale ne semble pas à l'ordre du jour, d'autant que l'industrie de la complémentaire santé déploie des stratégies d'influence pour défendre les intérêts d'un secteur qui, en 2017, collectait 38 milliards d'euros de cotisations.

Le système de soins entre libéralisme et pilotage

Si l'assurance maladie interprofessionnelle des origines a prospéré pour devenir une assurance sociale universelle, la gestion par les assurés, caractéristique du modèle « bismarckien », a en revanche totalement disparu. Une des conséquences de l'étatisation de la Sécurité sociale (chapitre II) est la mise en place, depuis le « plan Juppé » de 1995, d'un pilotage gouvernemental et budgétaire du système de soins.

La France ne se signale pas par un niveau de dépenses de santé particulièrement élevé. Avec 11,3 points de PIB en 2018 (maladie et invalidité), elle se situait à un niveau comparable au Japon, au Canada, à la Suède, à l'Allemagne ou à la Suisse, loin derrière les États-Unis (17 points). Compte tenu du plus faible niveau de vie en France, la dépense exprimée en euros par habitant (3 900 euros en 2018) y est même, selon l'OCDE, inférieure de plus de 10 % à ce qu'elle est par exemple en Allemagne, en Autriche ou aux Pays-Bas. La seule consommation de soins et de biens médicaux (hors revenus de remplacement et prestations liées à l'invalidité ou au handicap) représente 203 milliards d'euros, soit un peu moins de 9 points de PIB en 2018 ; près de la moitié (95 milliards) sont des soins hospitaliers, le quart (55 milliards) étant des soins de ville et environ 16 % des consommations de médicaments [Drees, 2019a]. Pour plusieurs raisons, les dépenses de santé évoluent

spontanément plus rapidement que le PIB. La première est structurelle : la santé est ce qu'on peut appeler un « bien supérieur » dont la consommation occupe dans le budget des ménages une part croissante avec le niveau de leur richesse. Ainsi, un pays riche comme la France a tendance, en période de prospérité, à s'équiper en dispositifs médicaux de pointe, à pratiquer des examens ou à mettre en œuvre des traitements relativement onéreux, quand un pays moins riche a recours à une gamme de soins plus accessible. La deuxième raison est le vieillissement : la part de la population âgée augmente dans les pays riches, faisant augmenter les dépenses. Il ne faut pas confondre ce phénomène avec l'augmentation de l'âge au décès, qui ne change pas grand-chose : les dernières années de vie sont les plus « médicalisées », quel que soit l'âge auquel elles interviennent. Enfin, dynamique propre au secteur de la santé, l'assurance maladie prend en charge des dépenses de biens et de services dont le prix et la quantité évoluent en fonction de l'offre de soins, des comportements des praticiens et de leurs prescriptions, du marché, de la technologie et de la réglementation.

Compte tenu de l'importance des dépenses de santé dans l'ensemble des dépenses publiques, différents outils sont utilisés pour maîtriser l'évolution des dépenses. Depuis 1996, en application du « plan Juppé » de 1995, le vote annuel du PLFSS (Projet de loi de financement de la Sécurité sociale) est l'occasion de l'adoption par les parlementaires d'un Objectif national d'assurance maladie (Ondam). Véritable outil budgétaire de pilotage de santé, l'Ondam fixe un objectif annuel de croissance des dépenses d'assurance maladie, un objectif « décliné » dans l'ensemble de la politique de santé. Systématiquement dépassé jusqu'à la fin des années 2000, l'Ondam a toujours été sous-exécuté de 2010 à 2019, ce qui témoigne d'une contraction relative des dépenses publiques de santé. Les stratégies mises en œuvre pour « maîtriser les dépenses » publiques de santé combinent incitations, régulation des prix et pilotage de l'offre de soins.

Des dispositifs d'incitation financière contre la surconsommation

Une des plus vieilles recettes économico-politiques de régulation des dépenses de santé en France est le principe du *copaiement* : conformément à la théorie économique de l'*aléa moral* (qui est une machine de guerre contre la dépense publique), chaque personne doit prendre en charge une partie du prix de ses dépenses médicales afin que celles-ci apparaissent coûteuses, ce qui incite à ne réaliser que les actes (ou les arrêts de travail) vraiment nécessaires. C'est en

vertu de ce raisonnement que le « ticket modérateur » puis le « forfait hospitalier » ont été mis en place (voir *supra*). Plus tard, alors que le ticket modérateur était de plus en plus pris en charge par les complémentaires santé, l'État a institué les « franchises médicales » que les complémentaires santé n'ont pas le droit de rembourser : un montant compris entre 0,50 euro et 2 euros sur les médicaments, transports et actes paramédicaux, plafonné à 50 euros par an, et une « participation forfaitaire de 1 euro » sur toutes les consultations. De même, la prise en charge des congés maladie par la Sécurité sociale est limitée : le remboursement par la Sécurité sociale n'est que de 50 % du salaire brut journalier et il fait l'objet d'un délai de carence de trois jours. Néanmoins, en ce cas, un complément jusqu'à 90 % du salaire brut et les délais de carence peuvent être pris en charge par une caisse de prévoyance privée.

En pratique, les dispositifs censés « responsabiliser financièrement les patients » ne sont pas toujours efficaces d'un point de vue sanitaire. Par exemple, l'absence de couverture peut conduire au report ou au renoncement aux soins [Després *et al.*, 2011], ce qui augmente le risque de développer des pathologies graves et finalement coûteuses. Les malades bénéficiant d'une meilleure prise en charge (complémentaire santé gratuite) ont une consommation en soins courants légèrement supérieure à celle des autres (à âge et état de santé donnés), mais rien n'indique que cette consommation soit excessive par rapport à leurs besoins réels ; ils ont par ailleurs le même recours aux soins hospitaliers [Raynaud, 2003]. Enfin, la mise en place d'un délai de carence pour rembourser les congés maladie ne réduit pas le nombre de jours total d'arrêt, mais engendre moins d'arrêts courts et plus d'arrêts longs [Breda et Toulemon, 2020]. La pertinence de la « responsabilisation financière » reste ainsi pour le moins largement discutée. En revanche, ces dispositifs réduisent, d'une façon discrète, la prise en charge sociale des dépenses de santé.

La régulation par les prix

Deuxième outil de régulation des dépenses, la Sécurité sociale fixe des tarifs (de consultation, d'actes, de prix des médicaments), négociés avec les professionnels de santé et qui servent de base au remboursement. Certains tarifs correspondent à la réalité du prix : c'est le cas par exemple d'une consultation chez un médecin de secteur 1 qui est effectivement facturée au tarif fixé ; d'autres tarifs sont une fiction ridiculement faible, comme pour les dispositifs optiques ou dentaires, dont le prix réel est très éloigné des bases de remboursement. Cette pratique est la source d'une tension entre

la Sécurité sociale et les offreurs de soins (praticiennes et praticiens, prothésistes, industrie pharmaceutique) qui font valoir que les tarifs fixés sont trop faibles ou ne correspondent pas à la réelle valeur du service rendu. Quand cette tension est forte, la Sécurité sociale peut être amenée soit à revaloriser ses tarifs, soit à autoriser les offreurs de soins à pratiquer des prix plus élevés qu'elle ne prendra pas en charge. Ainsi, depuis 1980, les médecins, dits « de secteur 2 », peuvent pratiquer des « honoraires libres » c'est-à-dire des « dépassement d'honoraires » par rapport au tarif remboursé ; il en va de même pour les cliniques privées, dont la tarification est libre mais dont les actes sont pris en charge sur la base des tarifs hospitaliers. Ces dépassements créent un marché pour les complémentaires santé qui s'engagent à les prendre en charge. Le risque d'une telle situation est de créer, de nouveau, une spirale inflationniste : plus les titulaires d'une complémentaire santé remboursant les dépassements d'honoraires sont nombreux, plus les offreurs de soins sont incités à pratiquer des tarifs élevés (si tous les patients sont couverts pour une consultation à 70 euros, pourquoi respecter le tarif à 40 euros ?). Cette « surassurance » est un des facteurs de l'explosion des dépenses de santé aux États-Unis, où la dépense par patient est la plus élevée du monde. Une limite peut survenir si la Sécurité sociale ou les complémentaires santé passent des accords avec des réseaux d'offres de soins en échange d'une garantie sur des tarifs raisonnables. Dans le cadre de la législation actuelle en France, cette possibilité est restreinte et peu utilisée.

La régulation par l'offre de soins

Le troisième instrument de maîtrise des dépenses de santé est la régulation de l'offre de soins. La puissance publique tente, assez timidement, de réguler l'offre libérale, mais ses efforts se concentrent surtout sur l'offre publique de soins hospitaliers, qu'elle pilote directement.

Une médecine de ville libérale en salarisation croissante. — La médecine libérale a un rôle structurant dans le système français, mais elle n'en représente pas l'« essence ». En effet, si environ la moitié des médecins exercent une activité libérale, l'autre moitié est salariée, essentiellement à l'hôpital ou dans des établissements de soins, publics ou privés, et des regroupements de praticiens du type « maisons de santé ». Deux tiers des médecins généralistes sont libéraux, tandis que c'est seulement le cas de la moitié des spécialistes [Anguis *et al.*, 2018]. À l'inverse, la profession médicale la plus

nombreuse, celle des infirmières et infirmiers, est essentiellement salariée (86 % en 2016). Néanmoins, l'activité libérale s'y développe rapidement, notamment pour les soins à domicile en cohérence avec la politique d'encouragement des soins ambulatoires (hospitalisation à domicile, etc.) [Millien, 2018].

Sans remettre en cause la liberté d'installation des médecins ni le libre choix du médecin par le patient, les pouvoirs publics cherchent à les encadrer. Ainsi, depuis la loi Douste-Blazy de 2005, les assurés doivent déclarer un « médecin traitant » et les consultations chez les médecins spécialistes ne sont remboursées au tarif conventionné qu'à la condition d'avoir été prescrites par un généraliste (sauf pour les gynécologues, ophtalmologues, dentistes et psychiatres ou consultation urgente). Depuis 2008, en application de la loi Hôpital patient santé territoire (HPST), des agences régionales de santé (ARS) ont pour mission de coordonner l'accès aux soins, en lien avec les structures hospitalières et avec les médecins libéraux.

Un secteur hospitalier à la fois central et en crise. — Le système de santé français est qualifié d'hospitalo-centré, en raison de l'importance de l'hôpital dans la consommation de soins, mais également du rôle central, pour les soins et pour la formation des futurs médecins, des praticiens hospitaliers des centres hospitalo-universitaires (CHU) [Batifoulier *et al.*, 2018]. Depuis plusieurs décennies, la maîtrise de l'activité est un moyen central d'infléchir l'évolution des dépenses. L'hôpital public a donc servi à la fin des années 1990 de laboratoire du *New Public Management*, fondé sur des indicateurs de gestion censés mimer le fonctionnement du marché et rendre l'allocation des moyens publics plus efficace. Au début des années 2000, le financement de l'hôpital a ainsi été organisé autour de la « tarification à l'activité » (T2A), les subventions versées par la Sécurité sociale aux hôpitaux dépendant de la facturation de chaque acte effectué. Par ce système, les hôpitaux publics sont placés en concurrence avec les établissements privés pouvant délivrer les mêmes soins pour une subvention comparable (*via* les remboursements de l'AMO). Les effets pervers de ce système ont été depuis largement dénoncés, qu'il s'agisse de l'inadéquation des tarifs fixés, des lourdeurs administratives (une lourde activité de *reporting* de la part des personnels) et de la distorsion public/privé que le système induit : les établissements privés sont incités à optimiser leur comportement en fonction de la tarification pour délivrer des soins relativement peu coûteux et bien remboursés, et ils reportent ainsi sur l'hôpital les missions de service public qui sont sous-financées.

Un autre outil de régulation de l'offre de soins consiste à diminuer la capacité d'accueil des hôpitaux en réduisant le personnel et le nombre de lits. Cette politique, menée en continu depuis le début des années 2000, correspond à la fois à une stratégie de maîtrise des dépenses par augmentation du taux d'utilisation des ressources hospitalières, et à la volonté de promouvoir les soins « ambulatoires » dispensés par la médecine de ville et/ou *via* une prise en charge par l'hôpital sans hospitalisation. Ainsi, de 2000 à 2018, la France a réduit son nombre total de lits d'hôpitaux et son nombre de lits pour soins aigus de l'ordre de 20 %. Cette stratégie pour « gagner en efficacité » a révélé d'importantes limites : en témoigne le mouvement social massif qui a animé les hôpitaux, toutes professions confondues, au cours de l'année 2019, dénonçant les faibles rémunérations, l'insuffisance du personnel et la souffrance au travail. En témoigne également le manque de capacité de prise en charge, mis en évidence régulièrement en période d'épidémie grippale et bien plus fortement encore à l'occasion de l'épidémie de la Covid-19 ; la prise en charge des patients n'a été possible qu'au prix d'une mobilisation anormale des personnels et d'un report des soins programmés dont les conséquences sur les patients ne sont pas encore connues. Les mêmes difficultés se sont répétées fin 2020 et au premier semestre 2021.

Le défi de la dépendance

Situé aux frontières du risque santé (comprenant au sens large l'invalidité et le handicap — chapitre VII) et du risque vieillesse (chapitre IV), la perte d'autonomie liée à l'âge est l'un des « nouveaux risques sociaux » identifiés par les politiques publiques à la fin des années 1970. En effet, l'allongement de la durée de vie fait considérablement augmenter la part des personnes âgées en perte partielle ou totale d'autonomie. Ce risque est particulier car il n'est pas généralisé à tous les seniors : la prévalence de la dépendance avoisine 20 % chez les plus de 85 ans [Libault, 2019]. Mais, lorsqu'il se concrétise, il occasionne pendant plusieurs années des besoins de prise en charge dont le coût excède les ressources privées des personnes touchées, ce qui se traduit soit par une insuffisance de la prise en charge, soit par une pression financière importante sur les familles concernées. Ce risque justifie donc pleinement la mise en place d'un mécanisme d'assurance sociale.

Deux situations se présentent. Soit les personnes âgées dépendantes vivent en logement privé et ont recours à des personnels de soins à domicile indépendants ou salariés d'associations ou de structures

à but lucratif. Soit elles intègrent, par choix ou par nécessité, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ces derniers sont publics, associatifs ou privés à but lucratif. Les politiques publiques, par la réglementation et une politique de tarification, ont encouragé une standardisation des pratiques de prise en charge qui a favorisé le développement de grands groupes privés dans le secteur [Delouette et Nirello, 2016]. À domicile ou en EHPAD, les dépenses pour les actes non médicaux liés spécifiquement à la dépendance sont subventionnées par deux canaux : l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et des crédits d'impôts non spécifiques. Créée en 2001, l'APA (chapitre VII) est calculée en fonction d'un degré de dépendance évalué par un médecin et dépend du niveau de ressources du ménage ; elle permet la prise en charge de tout ou partie des heures d'aide à domicile à un tarif conventionné défini au niveau du département. La partie de l'aide non payée par l'APA — le « reste à charge » — fait l'objet d'un crédit d'impôt à hauteur de 50 % du coût de l'aide à domicile ou de 25 % des dépenses en EHPAD. Ce dispositif à la fois social et fiscal aboutit à une situation paradoxale et potentiellement inégalitaire : les personnes dépendantes à revenu faible et non soumis à l'impôt n'ont accès qu'à des aides limitées par le montant de l'APA correspondant à leur degré de dépendance, tandis que les personnes aisées bénéficient de crédits d'impôts plafonnés à 6 000 euros par an, quel que soit leur degré de dépendance [Carbonnier et Morel, 2018].

Publié en 2019, le rapport Libault est le dernier en date d'une longue série de rapports envisageant les enjeux de la dépendance. En reprenant les travaux de la Drees, il estime les dépenses liées au grand âge à 30 milliards d'euros en 2014, dont deux tiers sont liés directement à la santé et à l'hébergement, et un tiers aux dépenses spécifiques à la dépendance, soit 8 milliards de fonds publics et 2 milliards pour les ménages. Le rapport préconise d'augmenter ces dépenses de 9 milliards à l'horizon 2030. En 2020, le gouvernement a fait un timide pas en ce sens : il crée une nouvelle « branche » de la Sécurité sociale dédiée à la dépendance et rassemblant des ressources existantes dont celles de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ; il est prévu également d'allouer à cette branche 2 milliards d'euros supplémentaires en 2024. Mais, en 2021, l'institution peine à se mettre en place, alors même que la crise sanitaire de 2020 a rendu manifestes non seulement l'insuffisance dénoncée dans le rapport Libault de personnel qualifié et stabilisé dans les EHPAD, mais aussi les conséquences dramatiques que cette insuffisance peut avoir sur la qualité et la durée de vie des personnes hébergées.